

Test *czterech założeń*

Cztery szybkie eksperymenty in-session, które rozbijają TAF, nadmierną odpowiedzialność i mit unikalności obsesji.

CZAS: 20 min — wszystkie cztery razem Z terapeutą lub samodzielnie po psychoedukacji

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1985); Rachman (1997, TAF); Rachman i de Silva (1978); Shafran i wsp. (1996)

JAK UŻYWAĆ

Wykonaj **cztery eksperymenty** w sekwencji: (1) **TAF** — napisz „*będzie wypadek*”, oceń przyrost ryzyka; (2) **tort odpowiedzialności** — ile % wypadku to *Tvoja* myśl; (3) **sondaż** — zapytaj 5 osób o intruzję (90% odpowie TAK); (4) **ERP** — napisz intruzję 10× bez neutralizacji, monitoruj SUDS.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Eksperyment behawioralny (ang. *behavioural experiment*) **różni się** od restrukturyzacji poznawczej tym, że pacjent **działa**. Bennett-Levy i wsp. (2004): eksperymenty behawioralne dają **silniejsze** zmiany przekonań niż dyskusja. Cztery eksperymenty kwestionują cztery założenia OCD: **magiczne myślenie** (TAF), **pełna odpowiedzialność** (tort), **unikalność intruzji** (sondaż), **niemożność tolerancji** (ERP). Shafran i wsp. (1996): eksperymentalne wywołanie TAF u osób zdrowych daje *przejściowe objawy OCD-podobne* — TAF jest **czynnikiem sprawczym**. Rachman i de Silva (1978): **90% populacji** ma intruzję o tej samej treści, co osoby z OCD — normalizacja przez sondaż jest kluczowa.

01 ◎ Eksperyment 1 — TAF (magiczne myślenie)

Hipoteza pacjenta: „jeśli pomyślę o czymś złym, to się stanie lub stanę się winny/-a”.

KROK

WYNIK

Napisz na kartce: „*Będzie wypadek samochodowy w tym tygodniu*”. Ile % wierzysz, że **zwiększyłeś/-aś** ryzyko?

Test odwrócony: napisz „*wygram milion na loterii*”. Sprawdź za tydzień. Wygrałeś/-aś?

Wniosek: jeśli myśl *nie zadziałała* w pozytywną stronę, dlaczego miałyby działać w negatywną? *Symetria magii*.

02 ♀ Eksperyment 2 — Tort odpowiedzialności

Hipoteza pacjenta: „jeśli się stanie, to w 90% moja wina”.

WYPADEK SAMOCHODOWY BLISKIEJ OSOBY — WYMIEN WSZYSTKIE CZYNNIKI RYZYKA

— bez siebie najpierw

PO WYMIENIENIU: ILE % TO MOJA MYŚL

— zwykle < 0,01%

ILE % WCZEŚNIEJ CZUŁEM/-AM, ŻE TO JA

— porównaj

03 Eksperyment 3 — Sondaż wśród bliskich

Hipoteza pacjenta: „tylko ja mam takie myśli — coś jest ze mną nie tak”.

Zapytaj **5 osób, którym ufasz** (nie tłumacząc, że to ćwiczenie OCD): „Czy zdarza Ci się mieć niechcianą myśl, np. że jadąc samochodem mógłbyś/mogłabyś wjechać na pieszych, albo że mógłbyś/mogłabyś krzyknąć coś niewłaściwego na pogrzebie?”

OSOBA	ODPOWIEDŹ TAK/NIE	JAKĄ MYŚL PODAŁA
Osoba 1		
Osoba 2		
Osoba 3		
Osoba 4		

Spodziewany wynik: ~90% odpowie TAK (Rachman i de Silva, 1978). Twoje intruzje *nie są unikalne* — różnica to tylko Twoja **reakcja** na nie.

04 Eksperyment 4 — ERP z intruzją

Hipoteza pacjenta: „jeśli nie zneutralizuję myśli, lęk będzie rósł bez końca”.

KROK	SUDS (0–100)
Napisz intruzję 10 razy — bez neutralizacji .	Przed: ____
Po 5 minutach.	
Po 15 minutach.	
Po 30 minutach.	

05 Wnioski z całej sesji

CO POTWIERDZIŁY EKSPERYMENTY

— konkretnie

CO ZMIENIAM W CODZIENNYM PODEJŚCIU

— konkretny krok

Klucz: Bennett-Levy i wsp. (2004, *Oxford Guide to Behavioural Experiments*): eksperymenty behawioralne dają $d = 0,7-1,2$ zmiany przekonań — silniej niż sama dyskusja poznawcza. Mechanizm: pacjent **doświadcza**, że prognozy OCD są fałszywe — to silniejsze niż *słyszenie*, że są fałszywe. Każdy z czterech eksperymentów atakuje inną domenę przekonań (OCCWG): magiczne myślenie, odpowiedzialność, znaczenie myśli, niemożność tolerancji. Robić *razem* — efekt synergii. Wracaj do **kartki z wynikami** w trudnych momentach OCD. *To są Twoje dane*.